جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سعاد بدوي ابراهيم جبر
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** البدرشين **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 24202112100566 **رقم التليفون :** 01113832405 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 11-02-1942 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سعاد بدوي ابراهيم حجر
National ID: 24202112100566



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

سعاد
بدوى ابراهيم جبر
قريه البدرشين
مركز البدرشين - الجيزه

١٩٤٢/٠٧/٢١

٢٤٢٠٢١١٢١٠٠٥٦٦

KQ9250048

٠١١١٣٨٣٢٤٠٥
٠١١٤١٢٨٠٢٢

٢٤٢٠٢١١٢١٠٠٥٦٦ ٢٠٢٤/٠٧
ربة منزل

أنثى مسلمة أرملة

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٧/٢٩

National ID – Front &'Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مستشفى الحوامدية العام
قسم الأشعة التشخيصية
وحدة الماموجرام

Name:	Age: ..... years	Date: 12 - 9 - 2026

Mammography Report

- Screening / Follow up : Previous study : .....
- ACR..... (..... B .....).
- Both Breasts: (Symmetric / Asymmetric).
- Mass :
  - No: left breast UOQ showing hyperdense
  - Location: Spiculated lesion with irregular borders.
  - Size: with thick skin.
  - Shape:
  - Margin: - ~~Cluster~~ grouped micro calcification detected.
  - Density:
- Calcifications: By complementary U/S
  - No.:
  - Size: - Lt breast UOQ showing hypoechoic spiculated
  - Morphology: mass lesion 2.5x1 cm with satellites 7x9 mm.
  - Distribution: - left axillary Pathological LN detected.
- Associated findings:
  - Skin :
  - Nipple: - lesion associated with thickened skin 7mm &
  - Trabecular pattern: Peau d'orange.
  - Parenchymal Architecture:
  - Axillary LNs: - Rt breast showing no suspicious masses

Complementary Ultrasound if needed has revealed: .....

Overall conclusion and BI-RADS assessment:

..... left breast malignant looking lesion &
..... ipsilateral pathological LNs (BI-RADS 5) for
Tissue diagnosis & Dynamic MRI.

Done By Doctor / Maria Mahmoud

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]

Patient Name: - Mrs / Soaad Badawy
Referred by : - Dr., ***Hussein Turky***
Date : - 7 September 2026

LT BREAST SONOGRAPHY

- LT breast show UOQ 1 o'clock level peripheral part solid mass about 30x25mm sho9wing hypo echoic texture and irregular borders
- Smaller similar lesion seen outer to lesion about 9x7mm
- Associated axillary lymph node measures about 15x8mm sowing attenuated eccentric hilum fat
- LT breast shows normal parenchymal pattern with mixed fibro-glandular and fatty elements.
- Periareolar skin thickening and indurations
- No micro- or macro-calcification.
- No duct ectasia.

Conclusion: -

- *LT breast UOQ masses show suspicious criteria, Bi-rads 5 for histopathology*

Much Obliged,
Dr., Ahmed Daraka, FEBR

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]